今日論文 • 第 01 篇 公開全文

支氣管哮喘艾灸療法的療效與安全性：系統回顧與網絡 Meta 分析

Efficacy and safety of moxibustion therapy for bronchial asthma: a systematic review and network Meta-analysis

作者	Zheng Haizhen, Chen Baohao, Zou Hanlin, Li Yingjie, Wu Wenzhe, Huang Guomin
期刊	Journal of Traditional Chinese Medicine（2026年10月；46卷5期，頁 1047–1060）
識別碼	PMID 42958657 • DOI 10.19852/j.cnki.jtcm.20260910.001 • PMC13684388
取用	公開全文（PMC）

官方連結（點擊即可打開）

- PMC 全文 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13684388/
- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42958657/
- DOI https://doi.org/10.19852/j.cnki.jtcm.20260910.001

研究是什麼

系統回顧並以成對分析及網絡 Meta 分析，比較不同艾灸療法治療支氣管哮喘的療效與安全性，結局包括有效率、肺功能及免疫指標。

方法要點

- 檢索五個資料庫至 2025 年 7 月 27 日，納入評估艾灸治療支氣管哮喘的隨機對照試驗。
- 共納入 44 項 RCT，合計 3,401 名受試者。
- 以 Cochrane RoB 2 評估偏倚風險，並以 Stata 18 及 R 進行成對及網絡 Meta 分析。

主要結果

- 熱敏灸在長期第一秒用力呼氣容積（FEV_1）優於常規治療，標準化均差（SMD）0.45（95% CI 0.03 至 0.87）；哮喘控制測驗（ACT）平均差 0.81（95% CI 0.20 至 1.42）。
- 艾灸聯合常規治療，在提高有效率、改善肺功能與 ACT，以及調節免疫指標方面，整體優於單用常規治療。
- 累積排序（SUCRA）：間接灸在總有效率較前；常規治療聯合熱敏灸在肺功能、ACT、免疫球蛋白 E 及 CD4+/CD8+ 比值較前；常規治療聯合傳統懸灸在降低白介素-6（IL-6）較前。
- 所有與艾灸相關的不良事件均為輕微。
- 作者認為，與單用常規治療相比，聯合艾灸顯示整體優效；惟納入研究質量有限，需更高質量試驗驗證。

中醫診所臨床啟示

- 已診斷支氣管哮喘或喘證患者，可將艾灸（尤其熱敏灸或間接灸）作為吸入藥物等常規治療的輔助選項討論。
- 不能取代急救吸入藥或急性發作處理；出現急性氣促、發紺、說話困難或意識改變，須立即轉急症。

- 網絡排序只供參考，並非「最佳方案」的證明，須向患者說明證據質量有限。

限制與解讀注意

- 納入試驗方法學質量有限，網絡排序可能受異質性及偏倚影響。
- 長期效應主要見於熱敏灸與常規治療的部分比較，不宜外推至所有艾灸手法。
- 安全性結論僅反映已報告的輕微不良事件，急性重症哮喘患者不在本分析的門診適用範圍。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。